

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	子宮頸癌 Cervical Cancer				
編號	A31000-Q03-W-M05	制定者	R9 黃麗華	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解子宮頸癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

主要是由性接觸傳染，人類乳突病毒(Human papillomavirus, HPV)是子宮頸癌的主要致病因子，以 16、18 型病毒為主，此病毒喜好侵犯鱗狀上皮細胞，子宮頸癌的高危險族群包括抽煙、口服避孕藥、多產、家族子宮頸癌病史、性生活紊亂、過早年紀有性交、多重性伴侶、性病感染等。

根據 2009 年國際婦產科聯盟(International Federation of Gynecology and Obstetrics FIGO)將子宮頸癌之臨床分期分為五期：

FIGO 分期		TNM Categories
	Primary tumor cannot be assessed（主要腫瘤無法評估）	Tx
	No evidence of primary tumor（沒有腫瘤之證據）	T0
0	Carcinoma in situ (pre-invasive carcinoma)（原位癌）	Tis
I	Cervical carcinoma confined to uterus(extension to corpus should be disregarded)（子宮頸癌侷限在子宮）	T1
I	A Invasive carcinoma diagnosed only by microscopy（微侵襲癌）	T1a

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/13

FIGO 分期		TNM Categories
IA1	Stromal invasion no greater than 3.0 mm in depth and 7.0 mm or less in horizontal spread (微侵襲癌，水平徑不超過 7 毫米，子宮頸基質侵襲不超過基底膜下 3 毫米)	T1a1
IA2	Stromal invasion more than 3.0 mm and not more than 5.0 mm with a horizontal spread 7.0 mm or less (微侵襲癌，水平徑不超過 7 毫米，子宮頸基質侵襲為基底膜下 3-5 毫米之間)	T1a2
IB	Clinically visible lesion confined to the cervix or microscopic lesion greater than IA2 / T1a2 (肉眼可見腫瘤侷限在子宮頸或顯微病灶範圍超出 IA2/T1a2)	T1b
IB1	Clinically visible lesion 4.0 cm or less in greatest dimension (子宮頸腫瘤直徑不超過 4 公分)	T1b1
IB2	Clinically visible lesion more than 4.0 cm in greatest dimension (子宮頸最大腫瘤直徑超過 4 公分)	T1b2
II	Tumor invades beyond the uterus but not to pelvic wall or lower third of vagina (腫瘤侵襲已達子宮頸外組織，但未達骨盆壁及陰道下端 1/3)	T2
IIA	Without parametrial invasion (無子宮頸旁組織侵襲)	T2a
IIA1	Clinically visible lesion ≤4.0 cm in greatest dimension (子宮頸腫瘤直徑不超過 4 公分)	T2a1
IIA2	Clinically visible lesion >4 cm in greatest dimension (子宮頸最大腫瘤直徑超過 4 公分)	T2a2
IIB	With parametrial invasion (已有子宮頸旁組織侵襲)	T2b
III	Tumor extends to pelvic wall and/or involves lower third of vagina and/or causes hydronephrosis or non-functional kidney (腫瘤侵襲達骨盆壁或達陰道下端 1/3 或造成腎臟水腫或無功能腎臟)	T3
IIIA	Tumor involves lower third of vagina, no extension to pelvic wall (腫瘤侵襲達陰道下端 1/3，未達骨盆壁)	T3a
IIIB	Tumor extends to pelvic wall and/or causes hydronephrosis or non-functional kidney (腫瘤侵襲達骨盆壁或造成腎臟水腫或無功能腎臟)	T3b
IVA	Tumor invades mucosa of bladder or rectum and/or extends beyond true pelvis (腫瘤侵襲膀胱或直腸之黏膜層，或延展超過真骨盆腔)	T4
IVB	Distant metastasis (遠處轉移)	M1

(二) 症狀

1. 早期症狀：輕微血絲的水樣分泌物、月經期延長，或是二次月經中間有點狀出血。陰道出血最常出現於性交後、停經後。
2. 中期症狀：貧血、腹部悶痛、可能摸到下腹有硬塊，若未加治療，陰道分泌物變成帶血暗色，而且會因組織感染及壞死而產生的難聞氣味。
3. 末期症狀：癌細胞轉移至其他器官如膀胱、大腸或肺部。因腫瘤過大可能會壓

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/13

迫泌尿系統，造成頻尿、少尿、小便失禁、解尿困難、腎積水；若壓迫到腸子，可能造成阻塞或便秘；若骨前淋巴腺受侵犯時，神經受壓迫會導致背部和腿部疼痛，行動困難。

4. 因此出現病灶後的婦女若未加以治療，其平均壽命為 2~4 年。

(三) 常見檢查

1. 子宮頸抹片檢查(Pap Smears): 抹片採檢過程相當簡單且快速、無痛。完成採檢，之後再經過染色後，於顯微鏡底下觀察是否有不正常細胞存在。
2. 子宮頸癌的腫瘤指標: SCC、CEA，可以作為治療前評估腫瘤進展的大略參考，治療後也可以使用該指標評估治療效果及作為追蹤的工具。
3. 陰道鏡檢查: 利用陰道鏡放大後，觀察子宮頸上皮病灶的位置及嚴重度。
4. 超音波檢查: 為第一線的診斷工具，可偵測出體內腫瘤的位置。腹部超音波檢查需於檢查前膀胱先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。
5. 病理切片檢查: 切取小部份子宮頸組織作病理化驗，了解病變的嚴重程度。
6. 子宮頸癌的分期診斷檢查: 其目的是要知道癌症是否已擴散到其他部位，如轉移到膀胱、直腸、淋巴結、肺等。常做的檢查有：

(1) 電腦斷層(CT scan)。

(2) 靜脈注射腎盂攝影(IVP): 子宮頸癌可能會導致輸尿管阻塞現象，所以藉由泌尿系統檢查來排除或確定癌細胞存在的可能性。

(3) 下腸胃道攝影術(LGI): 藉以檢查腸道系統有無阻塞或其他病變。

(4) 膀胱鏡(Cystoscope): 以確定是否有膀胱病變或是已有癌細胞侵襲膀胱黏膜。

(5) 直腸乙狀結腸鏡(Sigmoidoscope): 以確定是否已有癌細胞侵襲腸黏膜。

(6) 腹部超音波(Abdomen echo): 可早期發現子宮、卵巢或膀胱等器官病變。

(四) 常見治療

1. 依照年齡、癌症範圍、健康狀況決定治療方式，年輕女性想要生育，其可採取下列治療方式：

(1) 圓錐狀切除術(Conization): 若經病理切片檢查後發現為 CIN，可做子宮頸錐

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/13

狀切除，即能切除病變區，只要病變區切除，邊緣沒有異常細胞，則治癒率幾乎趨近百分之百。手術後無需住院，陰道會塞紗布以加壓止血，應教導病人自行移除後需注意陰道出血量。

(2)冷凍手術(Cryosurgery)：又稱冷凍治療，主要是使用極低溫液態氮去破壞不正常的組織細胞。

(3)電燒灼術(Electrocautery)：藉由儀器上的電流，直接作用在不正常的組織細胞上，再將病灶切除。手術後無需住院，陰道會塞紗布以加壓止血，應教導病人自行移除後需注意陰道出血量。

2. 侵入性子宮頸癌：以手術治療、化學藥物治療及放射線治療為主。

(1)第Ⅰ期及第Ⅱ期前期癌的病人多以手術為主。

(2)第Ⅱ期癌除了手術治療外，於手術後可能需要合併化學藥物或放射線輔助治療。

(3)第Ⅲ、Ⅳ期屬晚期，則可選用化學藥物或放射線治療。

3. 侵入性子宮頸癌的手術方式：為了預防再度復發或轉移，因此切除子宮是治療的最佳方法及主要的方式，其手術方式有：

(1)經陰道子宮切除(Vaginal hysterectomy,VH)：手術後無傷口，陰道會塞紗布以加壓止血，隔天由醫師移除，需注意陰道出血量。

(2)全子宮切除術(Total hysterectomy,TAH)：手術後下腹部有一橫式或直式的傷口，約 10-15 公分。橫式傷口無需拆釘；直式傷口因外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。

(3)子宮全切除及雙側輸卵管卵巢切除(TAH+BSO)：手術後同全子宮切除術(Total hysterectomy,TAH)。

(4)根除性全子宮切除(radical hysterectomy,RH)：此手術會在腹部放置 1-2 條引流管，引流腹內血水或腹水，一般會依當時引流情形才移除之。

(5)根除性全子宮切除及雙側骨盆淋巴結摘除(RH+BPLND)：手術後同根除性

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/13

全子宮切除(radical hysterectomy,RH)。

(五) 護理問題

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。
4. 身體心像紊亂／與子宮切除導致身體完整性受損有關。
5. 性生活型態改變／與子宮切除術後有關。

(六) 護理措施

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
 - (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
 - (2) 鼓勵及引導病人說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
 - (3) 運用同理心，耐心地傾聽病人心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
 - (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給病人，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕病人的焦慮感。
 - (5) 執行醫療處置或照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕病人的不安感。
 - (6) 執行醫療處置或護理照護時，應注重病人之隱私，勿過度裸露病人身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性回避。男性醫師幫女性病人做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
 - (7) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧(如按摩)、冥想等，以減輕焦慮。
 - (8) 轉移病人注意力，如聽音樂、聊天。
 - (9) 教導病人手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕病人害怕傷口疼痛之焦慮。
 - (10) 讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，以減少焦慮。

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/13

(11) 介紹相同的病人，彼此經驗分享。

(12) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。

(13) 隨時評估病人焦慮改善狀態。

(14) 若病人焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。

2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。

(1) 評估病人的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沈或表淺），並記錄疼痛的變化。

(2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。

(3) 與病人或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。

(4) 與病人或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。

(5) 評估病人使用疼痛控制方法的意願，在病人選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。

(6) 教導病人疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。

(7) 鼓勵病人運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。

(8) 教導病人放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。

(9) 教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。

(10) 避免腹部用力，如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。

(11) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。

(1) 每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。

(2) 每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。

(3) 監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。

(4) 教導病人或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/13

若有以上之情形應通知醫護人員。

(5)教導病人或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。

(6)教導病人或主要照顧者預防感染的方法，如接觸病人前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。

(7)視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。

(8)若病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。

(9)建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。

(10)評估病人營養狀況，給予飲食衛教。

4.身體心像紊亂／與子宮切除導致身體完整性受損有關。

(1)以主動傾聽、開放式問題，鼓勵病人表達感受。

(2)以不批判態度接受病人用憤怒來表達自己的挫折或感受。

(3)若病人陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。

(4)給予病人足夠的時間，讓病人接受失去的子宮的事實。

(5)以溫和漸進方式，鼓勵病人去觸摸及正視手術的傷口。

(6)醫師換藥時在旁陪伴，告知傷口情形，鼓勵其注視傷口，給予情緒支持如：可握住病人雙手等。

(7)當病人開始接受失去子宮的事實且情緒正向時，應給予鼓勵。

(8)隨時給予精神支持，幫助病人瞭解自己的長處，促進其整體感受，抵消因身體心像改變造成的恐懼。

(9)鼓勵病人走出病房，多接觸其它人、事、物，找尋適當方法抒解情緒。

(10)介紹相同病人，互相表達感受，彼此交換意見。

(11)鼓勵病人習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。

(12)若發現病人有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/13

(13)讓病人瞭解疾病過程及疾病對外觀上的改變，如：利用圖片、相片以澄清疑慮。

(14)與病人討論並列出失去子宮、輸卵管、卵巢對正常社交生活影響的範圍及因素。

(15)病人若有虔誠的宗教信仰，鼓勵可適當的應用，避免負向情緒。

(16)協助病人的親人(先生)接受病人失去子宮的事實，常表達關懷給予安全感。

5.性生活型態改變／與子宮切除術後有關。

(1)主動了解與尊重的態度接受病人對性問題的感受及想法。

(2)鼓勵病人與配偶（性伴侶）表達性困擾及性相關的焦慮情緒。

(3)完整評估病人性生活形態、性活動頻率、性功能障礙的情況。

(4)了解病人對性困擾所產生之性偏見，釐清性問題發生的導因，協助矯正。

(5)協助病人與配偶（性伴侶）雙向溝通，建立良好互動，減少性生活恢復過程的壓力。

(6)提供書面、衛教單張、錄影帶、幻燈片，待病人與配偶閱讀後，再與病人及配偶（性伴侶）討論，提供正確的性知識，以增強病人與配偶（性伴侶）學習性生活調適之能力。

(7)鼓勵病人與配偶（性伴侶）共同參與衛教與性諮商過程。

(8)病人呈現情緒障礙或焦慮反應時，應終止會談，並適時提供有力的心理支持，建立性生活的信心，並增強正向的自我概念。

(9)衛教病人與配偶（性伴侶）性生活，包括口交、擁抱、親吻、愛撫、自慰、共同沐浴、按摩敏感地帶等，可以透過這些活動一樣可獲得性滿足。

(10)當病人出現需要醫療處置之潛在或現存的性問題時，給予適當轉介，如性諮商與行為治療。

（七）衛教指導

1.飲食方面

(1)一般而言，手術後視醫囑禁食至排氣或數天，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/13

(2)可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。

(3)建議病人 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

2. 傷口方面

(1)衛教手術後會有 1 個橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。

(2)每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。

(3)手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。

(4)換藥步驟及方法：將無菌食鹽水滴至無菌棉棒，以傷口為中心點，由內向外塗擦清潔至傷口周圍外至少 5 公分處，再將無刺激性優點藥水滴至無菌棉棒塗擦消毒，約停留 20-30 秒，最後再使用無菌食鹽水將優點藥水擦去，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。

(5)教導病人需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。

(6)教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。

(7)出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

3. 傷口疼痛方面

(1)教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。

(2)衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

4. 活動方面

(1)衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/13

循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵病人早期下床活動。

(2)手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。

(3)衛教避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

5. 衛生方面

(1)手術後導尿管一般會留置大約 7-14 天，或是依當時恢復情形而定，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理。視醫囑協助導尿管膀胱訓練，之後再視訓練情形移除導尿管。移除導尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。若移除導尿管後；無法解尿或是解尿不乾淨會教導自我導尿法，其消毒方式採清潔即可。

(2)手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨，避免感染。

(3)如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。

(4)病人身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 4-6 週可恢復性生活。

7. 其他方面：

(1)出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	11/13

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)．*產科護理學*（十版），新文京。
- (二) 黃莊彥、張芳維(2022)．子宮頸癌抹片篩檢登記報告中的更年期婦女．*台灣更年期醫學會會訊*，68(3)，17-19。
- (三) 李佳純、馮翠霞(2022)．淺談婦科癌症病人的心理困擾與支持—不僅僅只是疾病．*護理雜誌*，69(4)，20-26。
- (四) 陳慧祺(2021)．子宮頸癌．*聲洋防癌之聲*，170，8-15。
- (五) 鄭敏、王鵬惠(2021)．早期子宮頸癌接受子宮根治性手術後繼發膀胱功能障礙治療及預防之案例報告及文獻回顧．*婦癌醫學期刊*，54，19-22。
- (六) 姜嘉琦、王玉女(2021)．運用品質關懷模式照顧一位末期子宮頸癌年輕婦女之護理經驗．*長庚科技學刊*，35，171-181。
- (七) 衛生福利部統計處(2024)．*113 年死因統計結果*．取自
<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-82775-1.html>

七、附件

(略)

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	增加及修改定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題及衛教指導之內容。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(一)目新增定義說明。 2.第六項文獻參考資料更新。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第三項第三目之說明之 6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)及第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 4(3)新增手術後同(2)全子宮切除術(Total hysterectomy；TAH)。 3. 第三項第四目之 4(5)新增手術後同(4)根除性全子宮切除(radical hysterectomy；RH)。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	子宮頸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M05	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
		4. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	
109.08.18	3.6	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.7	1. 第三項第一目修訂衛生福利部死亡率統計年份與排名。 2. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.8	1. 第三項第一、三、四目說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.9	1. 第三項第三、四、六目說明內容修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。